RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DE MÉTHODOLOGIE CLINIQUE • CONFORME R2C & ECOS 2026

LE CARNET D'ERREURS DU MAJOR EDN

Le Système Actif pour Ne Plus Jamais Perdre de Points sur les Mêmes Pièges

Auteur & Éditeur : Ethan Cole • EDN Référence 2026
Méthodologie : Adapté du carnet d'audit cognitif de Hédi, Major des EDN 2025 (Rang 1)
Couverture : 28 Spécialités Médicales • 367 Items au Programme du 2e Cycle

« Les erreurs commises lors de vos entraînements ne sont pas des échecs : elles sont vos plus puissants vecteurs de mémorisation. À une seule condition : ne jamais les laisser s'évaporer. Chaque piège déjoué et consigné en une formule réflexe devient un point garanti le jour du concours national. »

— Dr Ethan Cole & La Méthode Major EDN

Architecture de ce Manuel d'Entraînement :
• **Pages 2 :** Les 3 Piliers de l'Active Recall et protocole de révision hebdomadaire (Spaced Repetition).
• **Pages 3 à 7 :** Les 50 Pièges Cliniques Classiques R2C analysés par spécialité (Cardiologie, Neurologie, Infectiologie, Pneumologie, Néphrologie, LCA & ECOS).
• **Pages 8 à 11 :** Vos Grilles Personnelles d'Audit à remplir après chaque concours blanc ou session SIDES.
• **Page 12 :** Tableau de bord de progression mensuelle et checklist des 15 derniers jours.

Format Pratique : Ce document est conçu pour être imprimé au format A4 relié ou utilisé en annotation numérique directe sur tablette (GoodNotes, Notability, Acrobat). Complétez rigoureusement chaque grille après chaque session de QCM.

1. Le Principe Fondamental du Carnet d'Erreurs

Le Piège de l'Illusion de Compétence : 90% des candidats commettent la même erreur stratégique tout au long de leur externat. Après un concours blanc ou une série de 50 QCMs sur tablette, ils consultent leur note globale (ex : 62%), éprouvent une déception passagère, parcourent rapidement la correction détaillée du collège, puis ferment l'application. En lisant la solution, le cerveau produit un sentiment d'évidence (« *Ah oui, bien sûr, c'était la ceftriaxone !* ») qu'il confond avec la maîtrise réelle. Deux semaines plus tard, confronté à une formulation légèrement modifiée du même piège clinique, le candidat refait exactement la même erreur.

La Révolution de l'Active Recall : Le carnet d'erreurs brise ce cercle vicieux. Il impose un traitement actif immédiat : extraire la racine cognitive de l'erreur, la synthétiser en une seule phrase percutante, et la revoir selon un calendrier d'espacement temporel (Spaced Repetition). La veille du concours national, vous ne devez plus relire 2 000 pages de cours : vous devez relire vos 150 formules personnalisées.

2. La Règle d'Or des 3 Piliers

PILIER 1 **Une Erreur = Une Seule Phrase**	**Ne recopiez jamais un paragraphe du cours.** Synthétisez le mécanisme clé en une formulation lapidaire et universelle. Si votre formulation dépasse deux lignes, c'est que vous n'avez pas isolé le piège. *Exemple : « Dissection aortique type A = Anticoagulation MORTELLE, angioscanner immédiat ».*
PILIER 2 **La Technique Toggle (Rappel Actif)**	Séparez toujours l'indice clinique de la réponse. Sur papier, pliez la feuille ou masquez la colonne droite avec votre main. Sur application, utilisez la fonction Toggle. Ne regardez jamais la solution sans avoir formulé à voix haute ou par écrit la réponse exacte en moins de 5 secondes.
PILIER 3 **L'Audit Hebdomadaire (Spaced Repetition)**	Bloquez impérativement **25 minutes chaque dimanche soir** pour balayer l'intégralité de votre carnet d'erreurs. Appliquez la règle des 3 coches vertes : dès qu'une notion est récitée parfaitement 3 dimanches consécutifs sans la moindre hésitation, elle est définitivement ancrée.

3. Taxonomie des 4 Types d'Erreurs aux EDN

Type d'Erreur	Mécanisme Cognitif	Correction Stratégique
Type A : Connaissance Pure (Rang A)	Le mécanisme ou la recommandation officielle n'était pas connu.	Apprendre la ligne de cours brute et créer une fiche flash immédiate.
Type B : Piège Sémantique & Inattention	Lecture trop rapide du libellé (« sauf », « en première intention », etc.).	Surligner systématiquement les négations et mots exclusifs avant de répondre.
Type C : Piège Diagnostique Différentiel	Confusion entre deux tableaux cliniques proches (ex : CBH vs paralysie du III).	Créer un tableau comparatif binaire centré sur le signe clinique discriminant.
Type D : Précipitation Temporelle	Réponse validée sous la pression de la montre sans vérification croisée.	S'entraîner systématiquement en temps réel strict (1 minute par QCM isolée).

3. Pièges Cliniques Fondamentaux : Cardiologie & Réanimation

Items 228, 232, 234, 236, 331, 332 — Consensus Collège SFC & SRLF

N° & Contexte Clinique	Piège R2C Redoutable	Formule Réflexe du Major (Active Recall)	Rang
#01 ACR en asystolie / RACS	Prescrire de l'amiodarone ou de la lidocaïne dès le début de l'arrêt.	**L'amiodarone est FORMELLEMENT PROSCRITE en asystolie ; réservée exclusivement à la FV/TV après le 3e choc.**	**Rang A**
#02 Dissection Aortique Type A	Anticoaguler le patient suspectant un infarctus du myocarde devant la douleur thoracique.	**L'héparine est MORTELLE en cas de dissection aortique. Angioscanner en urgence absolue avant tout traitement antithrombotique.**	**Rang A**
#03 OAP cardiogénique sous dérivés nitrés	Administrer des dérivés nitrés chez un patient hypotendu ou avec atteinte ventriculaire droite.	**Dérivés nitrés STRICTEMENT CONTRE-INDIQUÉS si PAS < 100 mmHg ou SCA du ventricule droit (risque d'effondrement tensionnel).**	**Rang A**
#04 Tamponnade Péricardique	Administrer des diurétiques pour drainer l'épanchement ou calmer la dyspnée.	**Les diurétiques et vasodilatateurs sont FORMELLEMENT CONTRE-INDIQUÉS : ils effondrent le retour veineux et provoquent l'arrêt cardiaque.**	**Rang A**
#05 SCA ST+ Inférieur	Oublier de réaliser les dérivations complémentaires droites et postérieures.	**Dérivations V3R, V4R et V7-V8-V9 SYSTÉMATIQUES devant tout ST+ inférieur pour dépister l'extension au ventricule droit.**	**Rang A**
#06 Choc Septique & Remplissage	Retarder l'introduction des amines vasopressives jusqu'à la fin complète du remplissage liquidien.	**Noradrénaline précoce dès que PAM < 65 mmHg sans attendre la fin des 30 mL/kg de cristalloïdes si hypotension sévère.**	**Rang A**
#07 Intoxication aux Stabilisants de Membrane	Administrer des antiarythmiques de classe I ou des bêtabloquants pour tachycardie à QRS larges.	**Traitement antidote unique : Bicarbonate de sodium molaire 8,4% IV (250 mL en flash) pour neutraliser le bloc sodique.**	**Rang B**
#08 Endocardite Infectieuse sur Prothèse	Démarrer l'antibiothérapie probabiliste avant de réaliser la série complète d'hémocultures.	**3 paires d'hémocultures espacées de 30 min sur 2 heures AVANT toute antibiothérapie, sauf état de choc hémodynamique.**	**Rang A**

4. Pièges Cliniques Fondamentaux : Neurologie & Urgences Neuro

Items 89, 93, 94, 95, 96, 339 — Consensus Collège CEN & Collège CNER

N° & Contexte Clinique	Piège R2C Redoutable	Formule Réflexe du Major (Active Recall)	Rang
#09 AVC Ischémique Aigu & Pression Artérielle	Vouloir normaliser immédiatement la tension artérielle lors de l'admission en UNV.	**Respecter scrupuleusement la poussée hypertensive : ne traiter que si PA > 185/110 mmHg (si thrombolyse) ou > 220/120 mmHg (sans thrombolyse).**	**Rang A**
#10 Claude Bernard-Horner Douloureux	Penser d'abord à une tumeur de l'apex pulmonaire (Pancoast) chez un sujet jeune.	**CBH douloureux unilatéral récent = Dissection de la carotide interne cervicale jusqu'à preuve du contraire (Angio-IRM immédiate).**	**Rang A**
#11 Confusion + Ataxie chez l'Alcoolique	Perfuser immédiatement un sérum glucosé pour corriger une éventuelle hypoglycémie.	**Vitamine B1 (Thiamine) IV à forte dose TOUJOURS AVANT le sérum glucosé (risque de déclencher un Wernicke irréversible ou mortel).**	**Rang A**
#12 État de Mal Épileptique Généralisé	Injecter une benzodiazépine per os ou retarder la 2e ligne en attendant le réveil.	**Clonazépam 1 mg IVL à T=5 min. Si persistance à T=10 min : 2e ligne antiépileptique IV (Lévétiracétam ou Acide valproïque 40 mg/kg).**	**Rang A**
#13 Céphalée Brutale en Coup de Tonnerre	Éliminer une hémorragie sous-arachnoïdienne sur un scanner cérébral normal réalisé à H+1.	**Scanner cérébral sans injection en urgence. Si normal, Ponction Lombaire obligatoire après la 6e heure pour spectrophotométrie.**	**Rang A**
#14 Myasthénie Auto-Immune Décompensée	Prescrire des bêtabloquants, aminosides ou macrolides pour une infection intercurrente.	**Contre-indication ABSOLUE des aminosides, fluoroquinolones, macrolides et bêtabloquants (risque d'apnée aiguë par bloc neuromusculaire).**	**Rang A**
#15 Syndrome Malin des Neuroleptiques	Prendre l'hyperthermie et la tachycardie pour une infection bactérienne banale.	**Hyperthermie + Rigidité plastique en tuyau de plomb + Rhabdomyolyse = Arrêt immédiat de tout neuroleptique + Réanimation + Dantrolène.**	**Rang B**
#16 Paralysie Faciale Périphérique	Prescrire une corticothérapie sans vérifier l'occlusion palpébrale et sans larmes artificielles.	**Protéger impérativement la cornée (pansement occlusif nocturne + larmes artificielles le jour) pour prévenir la kératite neuroparalytique.**	**Rang A**

5. Pièges Cliniques Fondamentaux : Infectiologie & Pneumologie

Items 146, 151, 153, 155, 158, 203, 204 — Consensus Collège SPILF & SPLF

N° & Contexte Clinique	Piège R2C Redoutable	Formule Réflexe du Major (Active Recall)	Rang
#17 Méningite Bactérienne du Nourrisson/Adulte	Injecter l'antibiotique et attendre l'examen cytobactériologique pour prescrire la cortico.	**Dexaméthasone IV 10 mg administrée AVANT ou CONCOMITAMMENT à la première dose de Ceftriaxone (réduit mortalité et surdité).**	**Rang A**
#18 Coqueluche du Nourrisson (Bordetella)	Interpréter une hyperlymphocytose isolée comme une banale virose d'accompagnement.	**Hyperlymphocytose > 50 000/mm³ liée à la toxine pertussique = Critère de gravité MAJEUR (coqueluche maligne avec défaillance défaillance polyviscérale).**	**Rang A**
#19 Infection à Chlamydia & Gonocoque	Traiter une urétrite gonococcique par ceftriaxone seule sans couvrir Chlamydia trachomatis.	**Traitement combiné systématique : Ceftriaxone 1 g IM dose unique PLUS Doxycycline 100 mg x 2/j pendant 7 jours.**	**Rang A**
#20 Pneumonie Aiguë Communautaire (PAC)	Associer d'emblée une céphalosporine de 3e génération chez un sujet jeune sans comorbidités.	**Amoxicilline 1 g x 3/j per os en première intention. Si échec à 48-72h : adjonction d'un macrolide (suspicion de germe atypique Legionella/Mycoplasma).**	**Rang A**
#21 Tuberculose Pulmonaire Bacillifère	Attendre le résultat des cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen (6 semaines) pour isoler.	**Isolement respiratoire type « Air » (chambre seule, masque FFP2 pour soignants) DÈS LA SUSPICION clinique ou radiologique.**	**Rang A**
#22 Embolie Pulmonaire à Haut Risque	Réaliser un angioscanner thoracique chez un patient instable avec choc cardiogénique franc.	**Échocardiographie transthoracique (ETT) au lit du patient. Si dilatation du VD et instabilité : Thrombolyse systémique immédiate.**	**Rang A**
#23 Pneumothorax Spontané Sous Tension	Attendre le cliché de radiographie pulmonaire en inspiration/expiration pour agir.	**Diagnostic STRICTEMENT clinique : turgescence jugulaire, hypotension, asymétrie. Exsufflation à l'aiguille immédiate au 2e EIC.**	**Rang A**
#24 Exacerbation Sévère de BPCO	Augmenter le débit d'oxygène à 15 L/min au masque à haute concentration pour saturer à 100%.	**Objectif SpO2 STRICT entre 88% et 92% (risque d'hypercapnie majeure et de coma par perte de la commande hypoxique).**	**Rang A**

6. Pièges Cliniques Fondamentaux : Néphrologie & Endocrinologie

Items 242, 243, 245, 258, 260, 266 — Consensus Collège CUEN & CEEDMM

N° & Contexte Clinique	Piège R2C Redoutable	Formule Réflexe du Major (Active Recall)	Rang
#25 Hyperkaliémie Aiguë Menaçante (> 6,5 mmol/L)	Injecter du furosémide ou des résines échangeuses d'ions en première urgence.	**Première mesure immédiate : Gluconate de Calcium 10% IV (1 ampoule en 3 min) pour antagoniser l'effet myocardique (sauf intoxication digitalique).**	**Rang A**
#26 Acidocétose Diabétique Sévère	Démarrer l'insuline IV sans avoir vérifié la kaliémie sérique du patient.	**NE JAMAIS débuter l'insuline si K+ < 3,3 mmol/L. Recharger d'abord en potassium pour éviter un arrêt cardiaque par hypokaliémie foudroyante.**	**Rang A**
#27 Insuffisance Surrénale Aiguë (ISA)	Attendre le résultat du dosage du cortisol plasmatique pour injecter l'hémisuccinate d'hydrocortisone.	**Urgence vitale absolue : Hydrocortisone 100 mg IV direct + Remplissage NaCl 0,9% SANS ATTENDRE les résultats biologiques.**	**Rang A**
#28 Hyponatrémie Hypo-osmolaire Profonde	Corriger trop rapidement l'hyponatrémie (> 12 mmol/L les premières 24h) avec du sérum salé hypertonique.	**Vitesse maximale de correction : < 8 à 10 mmol/L / 24h pour prévenir la myélinolyse centropontine (syndrome de démyélinisation osmotique irréversible).**	**Rang A**
#29 Insuffisance Rénale Aiguë Obstructive	Rechercher une néphropathie tubulo-interstitielle sans avoir éliminé un obstacle urinaire.	**Échographie rénale et des voies urinaires en urgence dans les 24h devant toute IRA pour éliminer une dilatation pyélocalicielle.**	**Rang A**
#30 Syndrome Néphrotique de l'Adulte	Conclure à un syndrome néphrotique pur sans avoir recherché d'hématurie ou d'HTA.	**Le syndrome néphrotique est impur dès présence d'un seul critère : HTA, Hématurie microscopique ou Insuffisance rénale organique.**	**Rang A**
#31 Inhibiteur de DPP-4 (Gliptines) et Rein	Penser que toutes les gliptines requièrent un ajustement posologique strict en cas d'insuffisance rénale terminale.	**La LINAGLIPTINE est la SEULE gliptine à élimination biliaire ne nécessitant aucun ajustement posologique, quel que soit le DFG.**	**Rang B**
#32 Adénome Corticosurrénalien (Incisidentalome)	Réaliser une biopsie percutanée de la surrénale devant une masse surrénalienne découverte fortuitement.	**Biopsie surrénalienne STRICTEMENT CONTRE-INDIQUÉE avant d'avoir formellement éliminé un phéochromocytome (risque de crise hypertensive mortelle).**	**Rang B**

7. Pièges Fondamentaux : LCA & Stations ECOS 2026

Épreuves de Lecture Critique & 160 Stations Cliniques Pratiques

N° & Contexte Clinique	Piège R2C Redoutable	Formule Réflexe du Major (Active Recall)	Rang
#33 Essai de Non-Infériorité	Se baser uniquement sur l'analyse en Intention de Traiter (ITT) pour conclure à la non-infériorité.	**L'analyse de non-infériorité exige la concordance stricte entre Per-Protocole (PP) ET Intention de Traiter (ITT) pour éviter le faux optimisme.**	**Rang A**
#34 Courbe ROC & Nouveau Biomarqueur	Conclure à l'utilité clinique d'un test prédictif sur la seule valeur p < 0,05 de l'Odds Ratio multivarié.	**Une variable peut être statistiquement associée sans améliorer le pouvoir discriminant : l'AUC doit augmenter significativement (test de DeLong / NRI).**	**Rang B**
#35 Facteur de Confusion vs Intermédiaire	Ajuster le modèle de régression multivariée sur une variable située sur la chaîne causale entre exposition et maladie.	**Une variable intermédiaire ne doit JAMAIS être incluse en variable d'ajustement : cela annule artificiellement l'effet causal réel de l'exposition.**	**Rang A**
#36 Modèle de Survie de Cox	Appliquer un modèle de régression de Cox sans tester l'hypothèse des risques proportionnels au cours du temps.	**Vérification obligatoire du postulat des risques proportionnels (analyse des résidus de Schoenfeld ou courbes Log-Log de la survie).**	**Rang B**
#37 Calcul du Nombre de Sujets Nécessaires (NSN)	Penser que le risque alpha (erreur de type I) influence le calcul sans spécifier la puissance statistique 1-bêta.	**Le NSN dépend de 4 paramètres fondamentaux : risque alpha (5%), puissance 1-bêta (80-90%), variance de la variable et différence minimale cliniquement pertinente.**	**Rang A**
#38 Station ECOS : Annonce de Mauvaise Nouvelle	Dévoiler immédiatement le diagnostic d'emblée dès les 30 premières secondes de la station.	**Dispositif officiel en 4 temps : Évaluer ce que le patient sait, poser un avertissement, délivrer l'information par paliers, laisser un silence d'assimilation.**	**Rang A**
#39 Station ECOS : Refus de Soin du Patient	Argumenter contre le patient ou céder immédiatement sans chercher l'origine de son refus.	**Explorer la représentation de la maladie, s'assurer de la clarté de l'information délivrée, consigner le refus après information des risques vitaux.**	**Rang A**
#40 Station ECOS : Prescription Médicamenteuse	Rédiger l'ordonnance sans avoir formellement vérifié les antécédents d'allergie et la fonction rénale.	**Demander systématiquement au patient : « Avez-vous déjà fait une allergie à un médicament ? Êtes-vous enceinte ? » (Points éliminatoires).**	**Rang A**

Carnet d'Erreurs Personnel — Cardiologie & Médecine d'Urgence

Items prioritaires : Items 228 à 238, 331 à 338 • Remplissez chaque ligne immédiatement après vos QCMs / ECOS.

Mode d'emploi : 1. Datez la session. 2. Notez l'erreur que vous avez cochée à tort. 3. Formulez la règle d'or en **une seule phrase** percutante. 4. Cochez les cases **J+7, J+14, J+28** chaque dimanche lors de vos révisions de rappel actif.

N° & Date	Item & Contexte Clinique	Mon Erreur Initiale	La Vérité Clinique / Règle Majore	Check Hebdo
#01 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#02 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#03 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#04 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#05 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#06 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#07 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28

Carnet d'Erreurs Personnel — Neurologie & Maladies Infectieuses

Items prioritaires : Items 89 à 102, 143 à 168 • Remplissez chaque ligne immédiatement après vos QCMs / ECOS.

Mode d'emploi : 1. Datez la session. 2. Notez l'erreur que vous avez cochée à tort. 3. Formulez la règle d'or en **une seule phrase** percutante. 4. Cochez les cases **J+7, J+14, J+28** chaque dimanche lors de vos révisions de rappel actif.

N° & Date	Item & Contexte Clinique	Mon Erreur Initiale	La Vérité Clinique / Règle Majore	Check Hebdo
#01 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#02 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#03 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#04 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#05 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#06 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#07 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28

Carnet d'Erreurs Personnel — Pneumologie, Néphrologie & Endocrinologie

Items prioritaires : Items 203 à 209, 240 à 267 • Remplissez chaque ligne immédiatement après vos QCMs / ECOS.

Mode d'emploi : 1. Datez la session. 2. Notez l'erreur que vous avez cochée à tort. 3. Formulez la règle d'or en **une seule phrase** percutante. 4. Cochez les cases **J+7, J+14, J+28** chaque dimanche lors de vos révisions de rappel actif.

N° & Date	Item & Contexte Clinique	Mon Erreur Initiale	La Vérité Clinique / Règle Majore	Check Hebdo
#01 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#02 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#03 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#04 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#05 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#06 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#07 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28

Carnet d'Erreurs Personnel — Pédiatrie, Gynécologie-Obstétrique & Chirurgie

Items prioritaires : Items 23 à 54, 340 à 355 • Remplissez chaque ligne immédiatement après vos QCMs / ECOS.

Mode d'emploi : 1. Datez la session. 2. Notez l'erreur que vous avez cochée à tort. 3. Formulez la règle d'or en **une seule phrase** percutante. 4. Cochez les cases **J+7, J+14, J+28** chaque dimanche lors de vos révisions de rappel actif.

N° & Date	Item & Contexte Clinique	Mon Erreur Initiale	La Vérité Clinique / Règle Majore	Check Hebdo
#01 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#02 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#03 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#04 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#05 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#06 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28
#07 .../...	Item N° : Mots-clés :	*Notez précisément le piège qui vous a induit en erreur...*	**Formule lapidaire (Rappel Actif) :** ...	■ J+7 ■ J+14 ■ J+28

8. Tableau de Bord de Progression aux Concours Blancs

Consignez ci-dessous l'évolution de vos scores après chaque concours blanc national ou session d'entraînement majeure. L'objectif n'est pas le score brut, mais la diminution progressive du taux de récidive d'erreurs sur les notions déjà consignées.

N° Concours Blanc	Date & Organisme	Score Brut (%)	Nb Erreurs Notées	Erreurs de Rang A	Audit à J+7 Validé
Concours Blanc #1	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON
Concours Blanc #2	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON
Concours Blanc #3	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON
Concours Blanc #4	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON
Concours Blanc #5	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON
Concours Blanc #6	... / ... (ex : Conférence SIDES)	... %	... erreurs	... / ...	■ OUI ■ NON

9. Le Protocole des 15 Derniers Jours Avant le Jour J

J-15 à J-7 : Verrouillage des Formules Majores
• Ne faites plus de nouvelles séries massives de QCMs inconnus qui risquent de créer un doute de dernière minute.
• Relisez l'intégralité de vos formules réflexes (pages 8 à 11) deux fois par jour en mode rappel actif masqué.
• Vérifiez à nouveau les 10 contre-indications médicamenteuses mortelles de rang A (dérivés nitrés/VD, héparine/dissection, amiodarone/asystolie).

J-6 à J-2 : Simulation Temporelle & Sérénité Mentale
• Revoyez les arbres décisionnels de réanimation et les grilles d'évaluation relationnelle des stations ECOS.
• Préparez votre matériel de concours (tablette conforme, convocations, pièce d'identité en cours de validité).

La Veille du Concours : Arrêt Total
• Fermez tous vos livres et tablettes à 16h00 au plus tard. Votre carnet d'erreurs a déjà fait son œuvre dans votre mémoire profonde.

ÉDITION OFFICIELLE EDN STORE & ETHAN COLE
Retrouvez l'intégralité des 28 Référentiels Médicaux R2C en format Word éditable et PDF HD imprimable.
Application Mobile Hors-Ligne disponible pour Android • Simulateur de QCMs interactif : **https://edn-store.vercel.app**